32. DER UNTERE GENITALAPPARAT

DAUER : 08:54 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem immersiven Video über den unteren Genitaltrakt erforschen wir die Embryologie der Vagina und des Uterus und beleuchten die Dynamik des posterioren Wachstums, das diese wesentlichen Strukturen bildet. Das gynäkologische Gleichgewicht wird durch die Analyse der Bewegungen zwischen Sakrum und Peritoneum und wie diese Interaktionen die Gesundheit der Fortpflanzungsorgane beeinflussen, behandelt. Durch die Konzentration auf Ungleichgewichte wie Fehlgeburten oder Endometriose bietet das Video faszinierende therapeutische Techniken, die auf Konzepten der energetischen Reinigung, des faszialen Gleichgewichts und transgenerationaler Verbindungen basieren. Dieser Ansatz ermöglicht es den Praktikern, zu lernen, wie man

DER UNTERE GENITALAPPARAT: EINE BIODYNAMISCHE BETRACHTUNG

EMBRYOLOGIE VON VAGINA UND UTERUS

Die Insertion der **Harnblase** auf Höhe des **Müller-Hügelchens**, das sich im Urogenitalsinus befindet, ist essenziell. Dieser Bereich umfasst die Blase, die Harnröhre und die Anheftung an die Vagina.

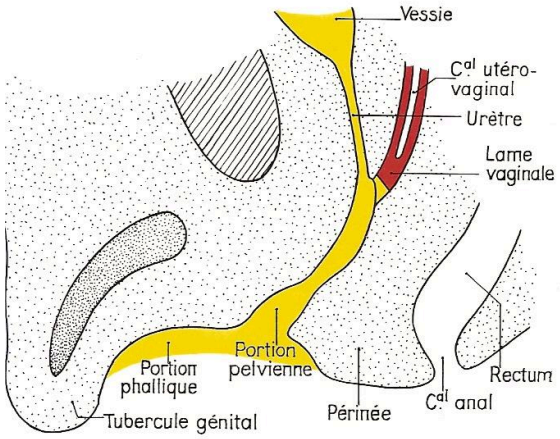


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

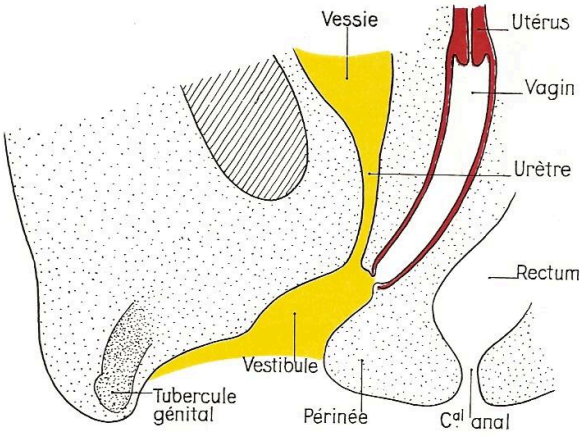


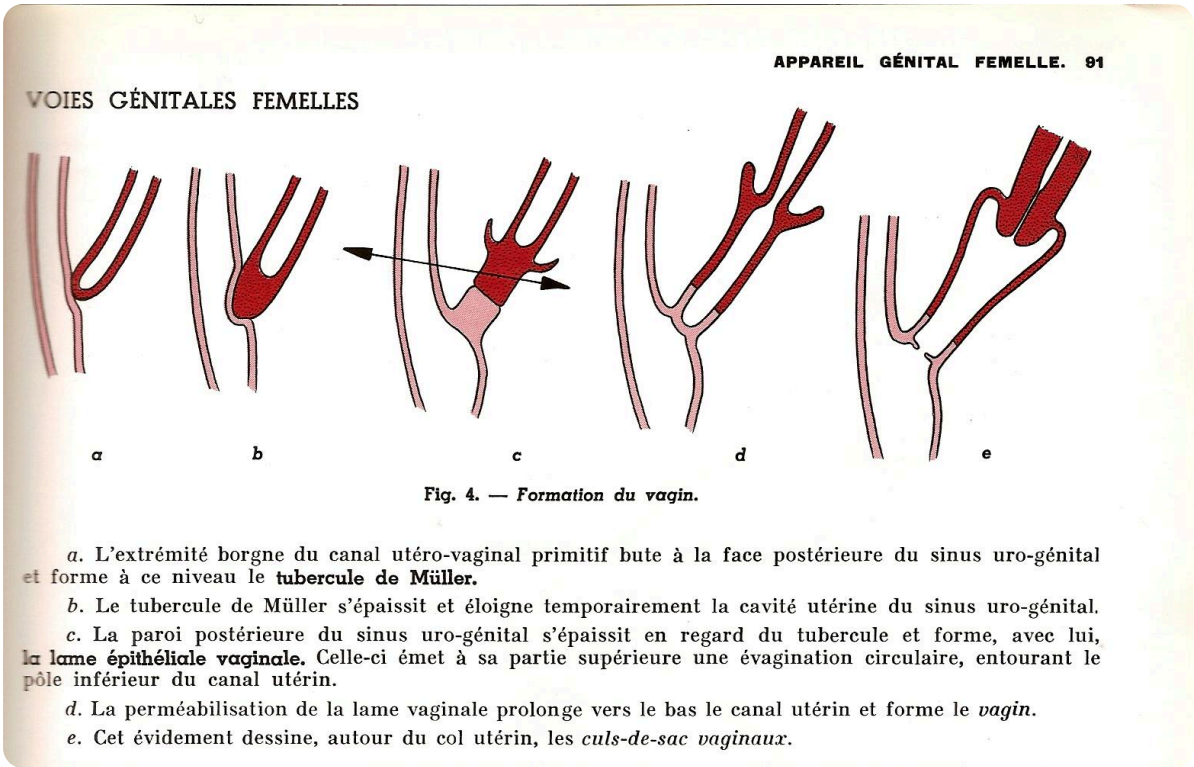
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

ABB. — Entwicklung des weiblichen Urogenitaltrakts

Die Vagina leitet sich vom **Mesoderm** ab, genauer gesagt vom Müller-Gang. Die Bildung der **Vaginalplatten** resultiert aus dem posterioren Wachstum des Sakrums und des Neuralrohrs.

Die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit dieses posterioren Teils schafft den Öffnungsraum der Vagina. Es ist die **postero-anteriore** Bewegung zwischen Niere und Sakrum, die diese Ausdehnung ermöglicht.

Das Müller-Hügelchen verdickt sich und wird dann gedehnt, nicht durch oberflächlichen Zug, sondern durch den schnelleren Schub des posterioren Teils. Dieses Phänomen führt zur Verlängerung und Bildung der Vagina und des Gebärmutterhalses.



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

ABB. — Vaginogenese

Die hintere Wand des Urogenitalsinus verdickt sich und bildet die Vaginalplatten, die sich öffnen und dehnen. Diese Dynamik ist ähnlich, wobei der hintere Teil schneller wächst.

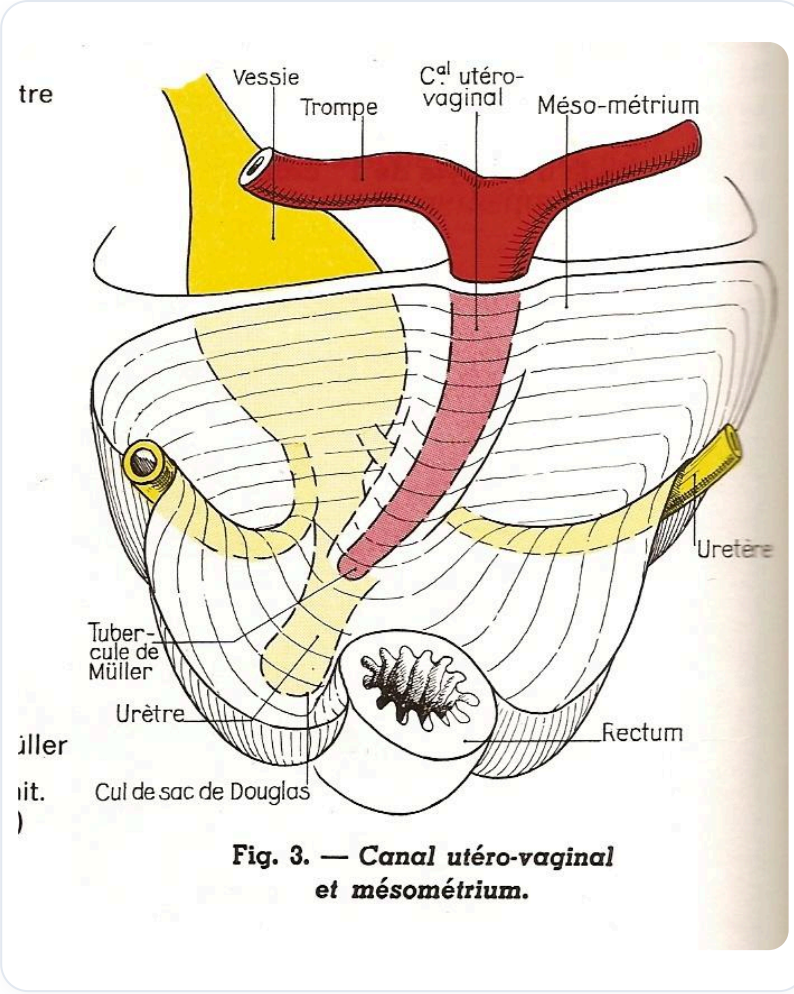


Fig. 3. — *Canal utéro-vaginal et mésométrium.*

ABB. — Utero-vaginaler Kanal

GYNÄKOLOGISCHES GLEICHGEWICHT UND BIODYNAMISCHE BEWEGUNG

Bei der Untersuchung des Uterus wird eine Bewegung zwischen dem **Kreuzbein** und dem **Peritoneum** wahrgenommen. Im Zusammenspiel dieser beiden Pole liegt das vaginale und uterine Gleichgewicht.

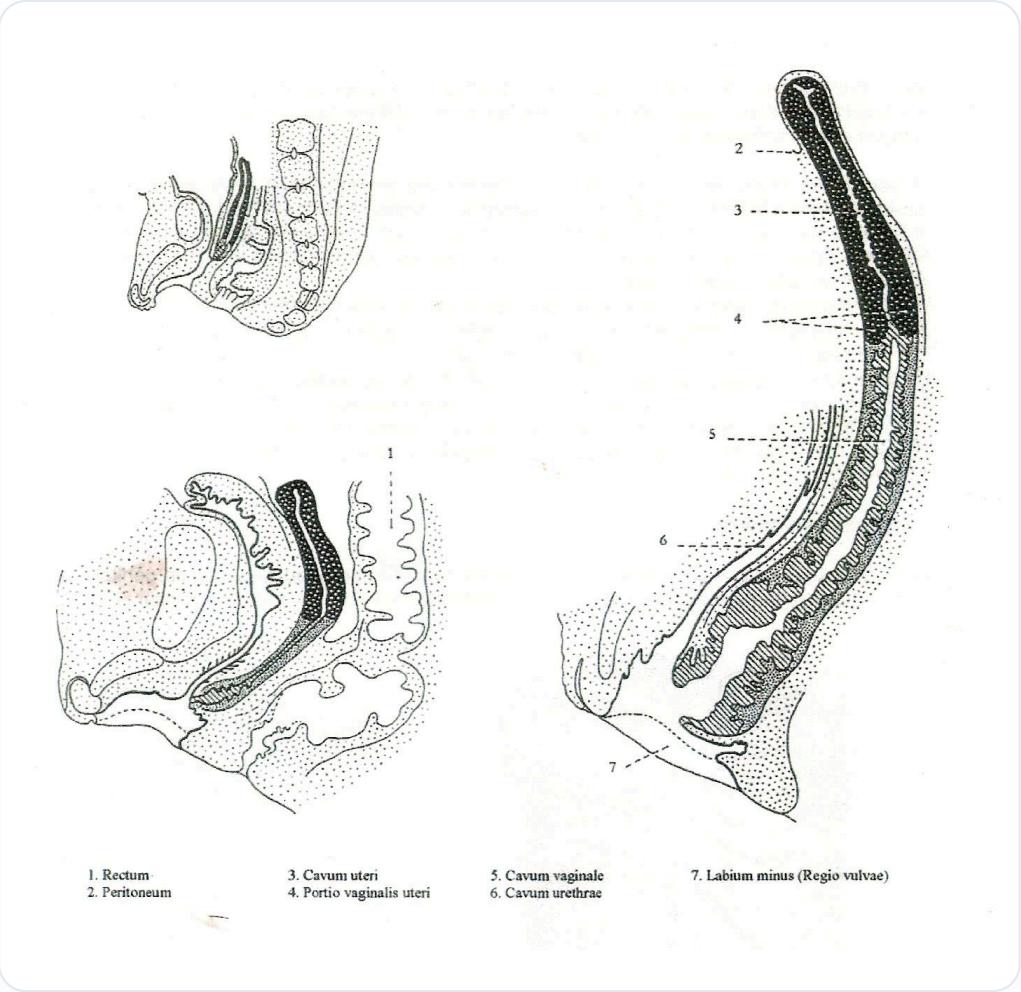


ABB. — Anatomie der weiblichen Gebärmutter

Auf gonadaler Ebene wird eine umgekehrte Bewegung im Bauchraum wahrgenommen, die dem Band in Richtung Schambein folgt, wie eine absteigende Welle.

Das Absinken des Kreuzbeins wird durch das Neuralrohr beeinflusst. Ein weiterer entscheidender Stützpunkt ist die Kombination von Schambein und Kreuzbein, die ein wesentliches fasziales Gleichgewicht des kleinen Beckens bei der Frau bildet.

Dieses Gleichgewicht beinhaltet eine absteigende Kraftlinie relativ zum Kreuzbein, die verschiedene Funktionen des weiblichen Körpers beeinflusst.

THERAPEUTISCHER ANSATZ BEI UTERINEN UNGLEICHGEWICHTEN

Situationen wie **Fehlgeburten** hinterlassen einen energetischen Abdruck im Uterus. Eine energetische Reinigung des Uterus wird dann notwendig.

Wir können uns dem Uterus mit einer **magnetischen Kraft** nähern und lernen, das Energiefeld aus der Ferne zu spüren. Der Praktiker nimmt eine Frequenz wahr, eine Zone der Wärme, die sich verdichtet, ein Zeichen der vorhandenen Energie.

Mein Ansatz besteht darin, die Bereiche zu "scannen" und zu identifizieren, die eine Reinigung benötigen. Es geht darum, den Geweben und Energien wieder Freiheit zu geben.

Eine **Uterusretroversion** beispielsweise kann zu kongestiven Phasen führen. Die Fernarbeit zielt darauf ab, das gynäkologische System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, in enger Verbindung mit dem **Gastrin**.

Die **Endometriose**, gekennzeichnet durch eine Gewebeproliferation, die in das Peritoneum aufsteigt, ist oft mit lumbalen und sakroiliakalen Schmerzen verbunden.

DIE INTRAPERITONEALE HÖHLE UND DIE TRANSGENERATIONALE DIMENSION

Bei der Frau besteht eine direkte Verbindung zwischen Gebärmutterhals, Eileitern und der **intraperitonealen Höhle**. Diese Höhle ist von großer Bedeutung, sie wird als "Himmel" oder ursprünglicher Raum wahrgenommen.

Jeder Zustand des Körpers stellt die bestmögliche funktionelle Antwort zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Diese Antwort wird durch unser Leben, aber auch durch das unserer Vorfahren beeinflusst.

Eine Uterusretroversion beispielsweise kann die beste Antwort sein, die der Körper gefunden hat, um ein **transgenerationales** oder tiefgreifendes persönliches Problem zu lösen.

Es ist essenziell zu verstehen, warum sich ein transgenerationales Muster so manifestiert. Die Therapie zielt darauf ab, diese "beste Antwort" zu entschlüsseln und die notwendige Befreiung anzubieten, wenn sie gewünscht wird.

Der Embryo veranschaulicht diesen Begriff perfekt: In jedem Entwicklungsstadium zeigt er die bestmögliche physiologische Reaktion.

DIE SEKUNDÄRE NEURULATION UND DIE BILDUNG DES FILUM TERMINALE

Das **Neuralrohr** ist mit einer posterioren kaudalen Eminenz verbunden, die einen Raum für Licht und Verbindung schafft. Man beobachtet die Kaudalsprosse und den terminalen Teil der **Chorda dorsalis**.

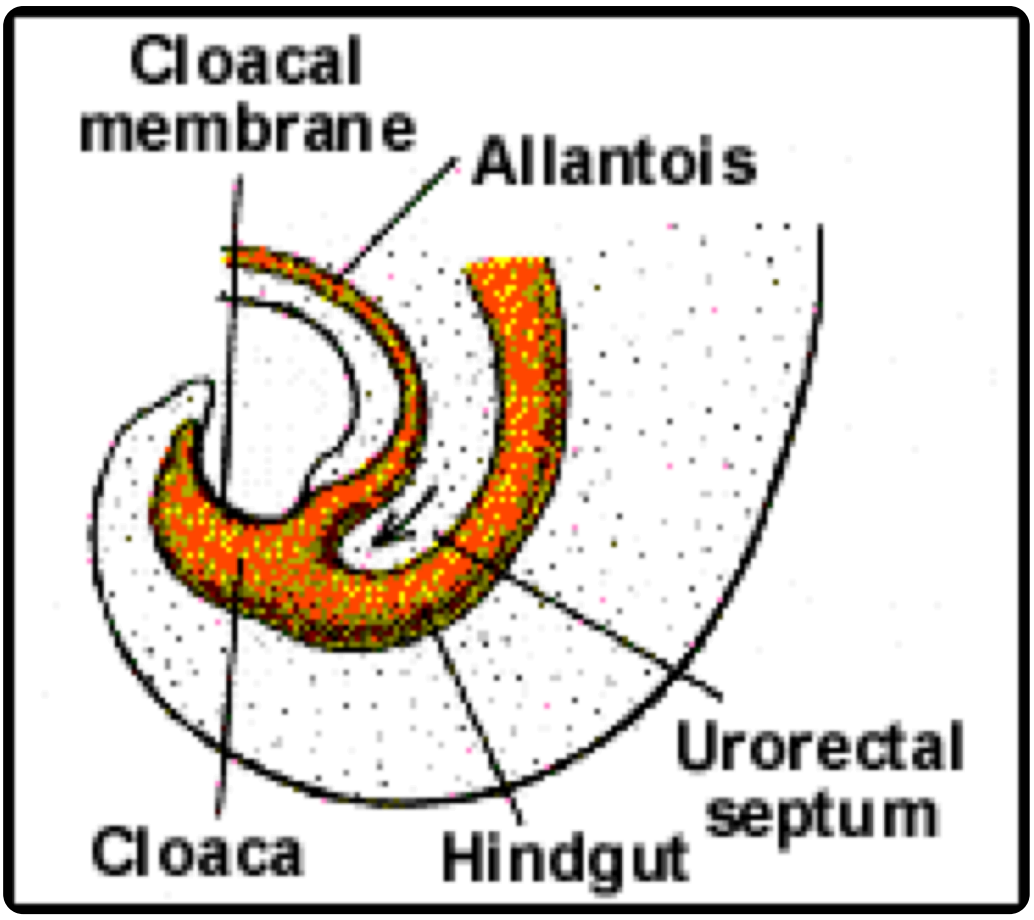


ABB. — Embryonale Kloakenentwicklung

Der Raum des Rektums und das Neuralrohr mit dem posterioren Neuroporus stehen in enger Beziehung. Eine Verbindung entsteht durch eine ausgeprägtere Entwicklungsbewegung im posterioren Teil.

Diese beinhaltet einen Verschluss und dann eine Wiedereröffnung, um diese Verbindung herzustellen. Dieser Prozess führt zum Auftreten des posterioren Neuroporus und zur Verlängerung zur Bildung des **Filum terminale**.

Dies wird als **sekundäre Neurulation** bezeichnet. Die Manipulation des Kreuzbeins offenbart diese differentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten, wobei sich die anfängliche Verbindung posterior verlängert.

Die Integration der kaudalen Eminenz gewährleistet die Kontinuität mit dem Neuralrohr und bildet diese aufsteigende sekundäre Neurulation.

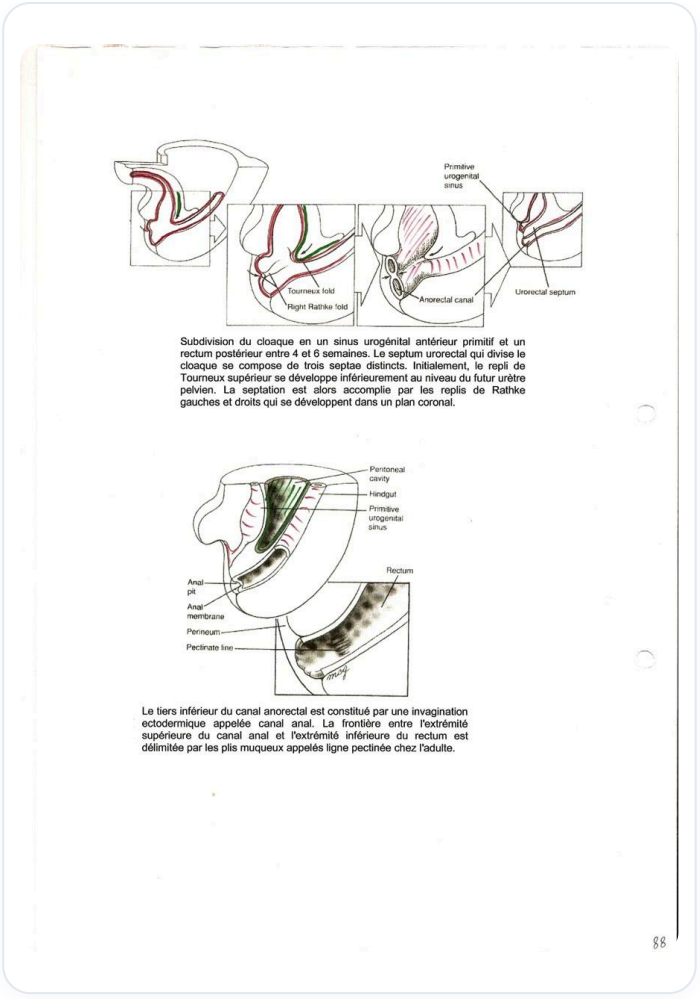


ABB. — Septierung der Kloake

ENTWICKLUNG DES PERINEUMS UND HEPATISCHER EINFLUSS

Auf Höhe des **Perineums** beobachten wir das Auftreten der unteren Extremitäten und einen ausgeübten Zug. Diese Bewegung ist tief mit dem Uterussystem verbunden.

Das Kippen der **Leber**, in Synergie mit dem Absinken des Neuralrohrs und des Kreuzbeins, beeinflusst die Entwicklung, die über das Ligamentum falciforme zur Linea alba zieht.

Diese hepatische Entwicklung führt zu einem Kippen, das den gesamten sich entwickelnden Uterusbereich beeinflusst. Es könnte Phänomene der Migration oder differentieller Züge im Zusammenhang mit der Uterusposition erklären.

Ein Band entwickelt sich zwischen Schambein und Nabel, das die Geschichte des Absinkens und der Uterusbildung umschließt.

Wie das Sternum die Geschichte unserer Flexion enthält, konzentriert dieses ventromediale Band (an der Linea alba) die Geschichte der gesamten posterioren Bildung, der **Gonadisation** und der **Uterisation** des Beckens.

Die Linea alba ist der Treffpunkt der gesamten **urogenitalen** Geschichte.